

# 聚焦解决模式的心理干预对急性白血病患者心理状态及睡眠质量的影响

蒋风云<sup>①</sup>

**【摘要】目的：**研究聚焦解决模式的心理干预对急性白血病患者心理状态及睡眠质量的影响。**方法：**选取2021年1月—2024年1月蚌埠医科大学第一附属医院102例急性白血病患者为研究对象。按随机数字表法将其分为研究组( $n=51$ )与对照组( $n=51$ )。对照组行常规护理干预，研究组同时行聚焦解决模式的心理干预。比较两组心理情绪[汉密尔顿抑郁量表(HAMD)、汉密尔顿焦虑量表(HAMA)、中文版心理弹性量表(CD-RISC)]、睡眠质量[匹兹堡睡眠质量指数(PSQI)]、癌性疲乏及护理满意度差异。**结果：**研究组干预后的HAMD、HAMA得分均低于对照组，CD-RISC得分高于对照组，差异均有统计学意义( $P<0.05$ )；研究组干预后的PSQI得分低于对照组，差异有统计学意义( $P<0.05$ )；研究组干预后的不同疲乏维度(行为、情感、感觉、认知)得分均低于对照组，差异均有统计学意义( $P<0.05$ )。研究组的护理满意度高于对照组，差异有统计学意义( $P<0.05$ )。**结论：**聚焦解决模式的心理干预有助于改善急性白血病患者心理状态及睡眠质量，可提高患者心理弹性，并减轻患者疲乏程度，患者护理满意度高。

**【关键词】** 急性白血病 聚焦解决模式 心理干预 常规护理干预 心理状态 睡眠质量

**The Impact of Psychological Intervention Focusing on the Solution Mode on the Psychological State and Sleep Quality of Patients with Acute Leukemia/JIANG Fengyun. //Medical Innovation of China, 2025, 22(13): 093-097**

**[Abstract] Objective:** To investigate the effect of psychological intervention focusing on the solution mode on the psychological state and sleep quality of patients with acute leukemia. **Method:** A total of 102 patients with acute leukemia in the First Affiliated Hospital of Bengbu Medical University from January 2021 to January 2024 were selected as the research objects. They were divided into study group ( $n=51$ ) and control group ( $n=51$ ) by random number table method. The control group received routine nursing intervention, while the study group received psychological intervention focusing on the solution mode meanwhile. The psychological mood [Hamilton depression scale (HAMD), Hamilton anxiety scale (HAMA), Chinese version of Connor-Davidson resilience scale (CD-RISC)], sleep quality [Pittsburgh sleep quality index (PSQI)], cancer-related fatigue and nursing satisfaction were compared between the two groups. **Result:** After intervention, the HAMD and HAMA scores of the study group were lower than those of the control group, and the CD-RISC score was higher than that of the control group, the differences were statistical significant ( $P<0.05$ ). The PSQI score of the study group after intervention was lower than that of the control group, the difference was statistical significant ( $P<0.05$ ). The scores of different fatigue dimensions (behavior, emotion, feeling, cognition) in the study group after intervention were lower than those in the control group, with statistical differences ( $P<0.05$ ). The nursing satisfaction of the study group was higher than that of the control group, with statistical difference ( $P<0.05$ ). **Conclusion:** Focusing on the solution mode of psychological intervention can help improve the psychological state and sleep quality of patients with acute leukemia, enhance their psychological resilience, reduce their fatigue, and increase their satisfaction with nursing care.

**[Key words]** Acute leukemia Focusing on the solution mode Psychological intervention Routine nursing intervention Psychological state Sleep quality

**First-author's address:** Department of Hematology, First Affiliated Hospital of Bengbu Medical University, Bengbu 233099, China

doi: 10.3969/j.issn.1674-4985.2025.13.021

①蚌埠医科大学第一附属医院血液科 安徽 蚌埠 233099

通信作者: 蒋风云

急性白血病是发生于人体造血系统的一种恶性增殖性疾病,该病的特点在于患者造血系统中某一细胞呈现出系统性的克隆增殖,基于血液流注浸润患者相关组织及器官,由此引发相应的临床表现,涵盖急性淋巴细胞白血病、急性髓系白血病等不同亚型<sup>[1-2]</sup>。该病会造成患者不良生理症状与严重生命威胁,同时还会对患者心理状态造成不利影响。相关调查显示,成年急性白血病初诊患者在化疗前直至第 4~5 次化疗后均保持严重的心理精力不足症状,同时存在严重的失眠、嗜睡等精神维度相关的生活质量损伤症状<sup>[3-4]</sup>。也正因此,良好有效的心理干预成为急性白血病患者治疗阶段的一项重要需求。聚焦解决模式的心理干预是一种关注个体优势资源与系统综合作用的新型心理干预模式,在诸多慢性疾病患者的心理干预中能以充分的尊重态度激发患者自我管理效能,对改善患者负性情绪、提高主观幸福程度及治疗依从程度均有积极作用<sup>[5-6]</sup>。本研究将其用于急性白血病患者护理干预中,并对干预后患者心理状态与睡眠质量进行分析。

## 1 资料与方法

### 1.1 一般资料

选取 2021 年 1 月—2024 年 1 月蚌埠医科大学第一附属医院 102 例急性白血病患者为研究对象。纳入标准:(1)均参考文献[7]《血液病分子病理诊断学》中骨髓检查确诊为急性白血病。(2)年龄 $\geq 18$  岁。(3)均为初次确诊白血病。排除标准:(1)伴精神系统疾病、原发肿瘤疾病、严重器质性疾病。(2)有沟通交流障碍。(3)有特殊情况(如参与其他研究等)。以随机数字表法分为研究组与对照组各 51 例。研究经蚌埠医科大学第一附属医院医学伦理委员会审批。患者及家属签字同意本研究。

### 1.2 方法

两组患者均持续干预 3 周。

对照组行常规护理干预,涉及疾病相关知识宣教、疾病治疗措施指导、负面心理情绪疏导等措施。

研究组同时行聚焦解决模式的心理干预。由血液科护理部组建聚焦解决模式的急性白血病患者心理护理干预小组,所有小组成员经聚焦解决模式的心理干预理论培训且考核合格后实施,根据本组患者数量将其区分为 5 个小组(每个小组人数为 9~11 人),行心理干预 2 次/周,60~90 min/次,共 6 次。(1)描述问题:护士通过召开小组成员会议进行小组成员介绍,帮助成员组成团体后为

其介绍聚焦解决模式的心理干预的基本理论和实施意义,帮助小组成员了解当前小组的建立目标(帮助小组成员积极缓解各项心理负面情绪并建立解决问题流程)、小组性质(以心理干预为目的急性白血病患者集体)、团体期望(小组成员在参加当前小组后对团体行为的目标和期望等),引导小组成员通过沟通交流制定团体契约。(2)构建目标:护士通过小组成员的集体交流,在培养小组成员凝聚力和信任力的基础上,引导和帮助小组成员诉说自身在急性白血病发生后存在的心理情绪,了解患者为解决自身心理情绪乃至现实问题所做出的努力,识别患者是否具有解决自身心理问题的资源与能力。而后护士根据小组成员的诉说内容帮助小组成员明确心理情绪中归属于自身的情绪内容及他人的引导性情绪内容,引导小组成员集体讨论不同类型的情绪为自身带来的心理影响,结合患者情绪问题为其制定合理的心理干预目标。(3)检查例外:护士在患者心理目标制定后协助小组成员进行例外体验,即当前患者所遭遇的问题在其他患者身上是否出现,以及当前患者面对相应问题所进行的解决策略、所花费的社会资源、所进行的自我引导等,帮助小组成员见识相同问题在不同个体上遭遇的差异性,通过体验例外,引导患者抒发心理情绪,最终由护士引导小组成员进行集体讨论,制定问题解决策略。(4)给予反馈:护士在问题解决策略制定后要求患者在后续面临相应问题时采取针对性策略,进而在小组集体讨论中对患者的解决效果进行集体评价,根据患者所采用的问题解决策略绘制思维导图,引导患者通过集体讨论分享问题解决感受,对患者在当前问题解决中体现的改变及进步提供积极反馈。(5)评价进步:护士在患者心理问题解决后通过小组成员会议,将当前小组成员在面临不同心理问题时的解决策略进行汇总统计,将策略整合后告知小组成员,同时再一次对患者当前的行为改变效果进行集体评价,以此赞扬和鼓励患者继续进步。同时护士在总结经验后应结合小组成员中不同患者的例外体验提出新问题,引导患者进行自我总结的同时帮助患者明确自身在解决此前问题与当前问题中体现出的进步与改变,通过个人回顾、团体回顾帮助患者充分体验到自身的进步之处。最后护士引导患者通过离别留言板分享自身感受,对患者的心理干预效果进行总结反馈后,引导患者积极面对未

来, 始终坚持以积极心态解决各项心理问题。

### 1.3 观察指标及评价标准

(1) 心理状态: 包括抑郁情绪、焦虑情绪、心理弹性三者内容。其中抑郁情绪与焦虑情绪分别以汉密尔顿抑郁量表 (HAMD)、汉密尔顿焦虑量表 (HAMA) 为评价工具, 两者量表均采用 Likert 5 级评分法 (0~4 分), HAMD 总分 0~96 分, 而 HAMA 总分 0~56 分, 得分越高表示患者抑郁、焦虑情绪越严重<sup>[8-9]</sup>; 心理弹性以中文版心理弹性量表 (CD-RISC) 为评价工具, 采用 Likert 5 级评分法 (0~4 分) 后总分 0~100 分, 得分越高表示患者心理弹性程度越强<sup>[10]</sup>。三者量表评估时间均为干预前后。(2) 睡眠质量: 以匹兹堡睡眠质量指数 (PSQI) 为评价工具, 总分 0~21 分, 得分越低表示患者睡眠质量越好<sup>[11]</sup>。评估时间为干预前后。(3) 癌性疲乏: 以癌因性疲乏量表为评价工具, 共有行为、情感、感觉、认知 4 个维度, 各项维度总分均为 0~10 分, 得分越高表示患者疲乏程度越严重<sup>[12]</sup>。评估时间为干预前后。(4) 护理满意度: 使用护理满意度调查问卷对两组患者护理满意度进行评估, 总分 0~10 分, 非常满意、基本满意、不满意的分值分别为  $\geq 9$  分、 $\geq 6$  分且  $< 9$  分、 $< 6$  分<sup>[13]</sup>。(非常满意 + 基本满意) 例数 / 总例数  $\times 100\%$  = 护理满意度。

### 1.4 统计学处理

以 SPSS 22.0 统计学软件为分析工具, 计量资料分析时以  $(\bar{x} \pm s)$  表示, 组间比较采用独立样本  $t$  检验, 组内比较采用配对  $t$  检验; 计数资料分析时以率 (%) 表示, 以  $\chi^2$  检验。 $P < 0.05$  为差异有统计学意义。

## 2 结果

### 2.1 基线资料

研究组中男 24 例 (47.06%), 女 27 例 (52.94%); 年龄 18~58 岁, 平均  $(40.96 \pm 6.51)$  岁; 病程 2~12 周, 平均  $(5.28 \pm 1.33)$  周。对照组中男 20 例 (39.22%), 女 31 例 (60.78%); 年龄 18~60 岁, 平均  $(42.27 \pm 5.85)$  岁; 病程 2~12 周, 平均  $(5.35 \pm 1.24)$  周。经统计学分析, 两组基线资料差异均无统计学意义 ( $P > 0.05$ ), 具有可比性。

### 2.2 心理状态

两组干预前的 HAMD、HAMA、CD-RISC 得分比较, 差异均无统计学意义 ( $P > 0.05$ ); 两组干预后的 HAMD、HAMA 得分均低于干预前, CD-RISC 得分均高于干预前, 差异均有统计学意义 ( $P < 0.05$ ), 研究组干预后的 HAMD、HAMA 得分均低于对照组, CD-RISC 得分高于对照组, 差异均有统计学意义 ( $P < 0.05$ )。见表 1。

表1 两组干预前后心理状态评分比较 ( $\bar{x} \pm s$ )

分

| 组别             | HAMD             |                   | HAMA             |                   | CD-RISC          |                   |
|----------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
|                | 干预前              | 干预后               | 干预前              | 干预后               | 干预前              | 干预后               |
| 研究组 ( $n=51$ ) | 44.52 $\pm$ 5.26 | 33.61 $\pm$ 5.28* | 37.25 $\pm$ 4.18 | 28.33 $\pm$ 3.84* | 62.83 $\pm$ 8.65 | 77.96 $\pm$ 7.89* |
| 对照组 ( $n=51$ ) | 43.86 $\pm$ 5.75 | 37.24 $\pm$ 5.65* | 37.36 $\pm$ 5.06 | 32.45 $\pm$ 4.25* | 62.91 $\pm$ 9.59 | 71.63 $\pm$ 8.85* |
| $t$ 值          | 0.605            | 3.352             | 0.120            | 5.137             | 0.044            | 3.813             |
| $P$ 值          | 0.547            | 0.001             | 0.905            | <0.001            | 0.965            | <0.001            |

\* 与本组干预前比较,  $P < 0.05$ 。

### 2.3 睡眠质量

两组干预前的 PSQI 得分比较, 差异无统计学意义 ( $P > 0.05$ ); 两组干预后的 PSQI 得分均低于干预前, 差异均有统计学意义 ( $P < 0.05$ ), 研究组干预后的 PSQI 得分低于对照组, 差异有统计学意义 ( $P < 0.05$ )。见表 2。

表2 两组干预前后PSQI得分比较 ( $\bar{x} \pm s$ )

分

| 组别             | 干预前              | 干预后              |
|----------------|------------------|------------------|
| 研究组 ( $n=51$ ) | 14.68 $\pm$ 3.53 | 7.28 $\pm$ 2.03* |
| 对照组 ( $n=51$ ) | 14.69 $\pm$ 3.95 | 9.92 $\pm$ 2.61* |
| $t$ 值          | 0.013            | 5.702            |
| $P$ 值          | 0.989            | <0.001           |

\* 与本组干预前比较,  $P < 0.05$ 。

### 2.4 癌性疲乏

两组干预前的不同疲乏维度 (行为、情感、感觉、认知) 得分比较, 差异均无统计学意义 ( $P > 0.05$ )。两组干预后的不同疲乏维度 (行为、情感、感觉、认知) 得分均低于干预前, 差异均有统计学意义 ( $P < 0.05$ ), 研究组干预后的不同疲乏维度 (行为、情感、感觉、认知) 得分均低于对照组, 差异均有统计学意义 ( $P < 0.05$ )。见表 3。

### 2.5 护理满意度

研究组的护理满意度高于对照组, 差异有统计学意义 ( $\chi^2=5.433$ ,  $P=0.020$ ), 见表 4。



表3 两组干预前后癌性疲乏评分比较 ( $\bar{x} \pm s$ )

分

| 组别         | 行为疲乏        |              | 情感疲乏        |              | 感觉疲乏        |              | 认知疲乏        |              |
|------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|
|            | 干预前         | 干预后          | 干预前         | 干预后          | 干预前         | 干预后          | 干预前         | 干预后          |
| 研究组 (n=51) | 7.26 ± 1.95 | 2.59 ± 0.48* | 7.15 ± 1.68 | 2.87 ± 0.45* | 8.14 ± 1.06 | 3.31 ± 0.58* | 8.32 ± 1.56 | 2.98 ± 0.54* |
| 对照组 (n=51) | 7.31 ± 1.86 | 4.08 ± 0.89* | 7.22 ± 1.35 | 4.16 ± 0.92* | 8.25 ± 1.18 | 4.57 ± 1.13* | 8.27 ± 1.25 | 4.35 ± 1.22* |
| t 值        | 0.133       | 10.523       | 0.232       | 8.995        | 0.495       | 7.084        | 0.179       | 7.333        |
| P 值        | 0.895       | <0.001       | 0.817       | <0.001       | 0.622       | <0.001       | 0.859       | <0.001       |

\* 与本组干预前比较,  $P<0.05$ 。

表4 两组护理满意度比较

例 (%)

| 组别         | 非常满意       | 基本满意       | 不满意       | 护理满意       |
|------------|------------|------------|-----------|------------|
| 研究组 (n=51) | 38 (74.51) | 12 (23.53) | 1 (1.96)  | 50 (98.04) |
| 对照组 (n=51) | 26 (50.98) | 16 (31.37) | 9 (17.65) | 42 (82.35) |

3 讨论

急性白血病患者在面临生命安全与生理痛苦威胁的同时, 其心理也会基于生理健康的变化产生诸多心理社会需求, 如学会处理悲伤情绪、放松缓解内心压力、与其他同患疾病患者联络等<sup>[14-15]</sup>。然而以往临床在急性白血病患者的护理干预中缺少对患者上述需求的重视, 在患者心理干预中多以言语沟通交流、负面情绪疏导等措施为主, 对患者心理负担的缓解效果较为有限。聚焦解决模式的心理干预是一种引导患者个人制定可行计划、充分挖掘个人潜力、有效解决当前问题、提高个人生活质量的心理干预模式, 该项模式以个人为中心的同时充分强调对患者内在潜力的挖掘和发展, 可有效帮助患者提高其适应能力与康复效果, 对患者的情绪、行为、角色均有良好的管理效果<sup>[16]</sup>。多项研究证实, 聚焦解决模式的心理干预对改善艾滋病患者的负面情绪有积极作用<sup>[17-18]</sup>。本研究将其用于急性白血病患者的护理干预中并取得良好效果。

首先本结果中干预后研究组的 HAMD、HAMA、PSQI 得分均较对照组低, CD-RISC 得分较对照组高 ( $P<0.05$ )。说明聚焦解决模式的心理干预在急性白血病患者中的应用对减轻患者抑郁焦虑情绪、改善患者睡眠质量、提高患者心理弹性均有非常积极的效果。与文献[19]研究结果相近。其次本结果中干预后研究组的各维度疲乏得分均较对照组低 ( $P<0.05$ )。与文献[20]研究结果相近, 说明聚焦解决模式的心理干预对减轻急性白血病患者的疲乏程度亦有积极效果。分析其原因可能在于聚焦解决模式的心理干预能通过小组团体的组建帮助患者构建相同疾病患者之间的有效链接, 进而通过团体交流、集体活动等措施充分为患者提供积极有效的社会支持, 利用例外体验帮助患者充分容纳急性白血

病治疗中相同及不同问题的解决经验, 经由给予反馈和评价进步帮助患者有效挖掘自身内心潜力并体验心理改变的快感, 最终充分达到提升患者心理负面情绪疏导效果的目的。而患者心理需求满足, 后期心理状态得到有效改善, 疲乏程度也获得明显好转。这也是本结果中研究组的护理满意度较对照组高的一项重要原因。还有研究证实: 聚焦解决模式的心理干预对优化白血病患者的应对方式亦有积极影响<sup>[21]</sup>。但本研究亦有规模较小的不足之处, 后续应扩大规模以进一步挖掘聚焦解决模式在急性白血病患者中的应用潜力。

综上所述, 聚焦解决模式的心理干预有助于改善急性白血病患者的心理状态及睡眠质量, 可提高患者心理弹性, 并减轻患者疲乏程度, 患者护理满意度高。

参 考 文 献

[1] 李粮健. 家庭赋权方案对急性白血病患者照顾者照顾能力的干预效果研究 [D]. 长春: 吉林大学, 2022.

[2] 黄可秀, 王云婧, 李迪, 等. 真实世界遗传学高危的急性髓系白血病患者临床结局分析 [J]. 中国肿瘤临床, 2023, 50 (3): 150-156.

[3] 叶艳欣, 尹西西, 于雅, 等. 成年人急性白血病初诊患者化疗期间症状的纵向变化研究 [J]. 中国实用护理杂志, 2022, 38 (17): 1292-1297.

[4] 林沛钰, 王爱平. 急性髓系白血病患者诱导缓解化疗期间症状与生活质量现状及影响因素分析 [J]. 护士进修杂志, 2022, 37 (12): 1136-1140.

[5] 张兵, 郭会敏, 栾玉泉, 等. 聚焦解决模式在心理干预中的应用及研究进展 [J]. 护士进修杂志, 2021, 36 (8): 704-707.

[6] 莫金华, 莫伟. 聚焦解决模式在提升原发性肝癌术后患者幸福感中的应用 [J]. 介入放射学杂志, 2022, 31 (7): 718-723.

[7] 高广勋, 董宝侠. 血液病分子病理诊断学 [M]. 西安: 第四军医大学出版社, 2016: 187-201.

[8] 赵寅, 万阳阳. 系统性护理干预在降低成人急性髓系白血病化疗期间口腔黏膜炎发生率中的应用 [J]. 川北医学院学报, 2022, 37 (2): 262-265.

# 前馈控制理论干预在产后护理中的应用及对产褥感染的预防效果

谢丽晶<sup>①</sup>

**【摘要】目的：**探讨前馈控制理论干预在产后护理中的应用及对产褥感染的预防效果。**方法：**选择 2023 年 4 月—2024 年 4 月于抚州市妇幼保健院分娩的 94 例产妇。根据随机数字表法分为对照组（采取常规护理）和观察组（实施前馈控制理论干预），各 47 例。比较两组产褥感染情况、不良情绪、疼痛、舒适度、生活质量及护理满意度。**结果：**观察组产褥感染发生率较对照组低，差异有统计学意义（ $P<0.05$ ）；护理后，观察组患者健康问卷（PHQ-9）、广泛性焦虑障碍量表（GAD-7）、疼痛数字评分法（NRS）评分均较对照组低，差异均有统计学意义（ $P<0.05$ ）；护理后，观察组舒适状况量表（GCQ）、健康调查简表（SF-36）、护理满意度各项评分均较对照组高，差异均有统计学意义（ $P<0.05$ ）。**结论：**前馈控制理论干预可预防产妇产褥感染发生，有效缓解其消极心理状态、疼痛，增加患者舒适度，还利于生活质量的改善，从而提升患者满意度。

**【关键词】** 产褥感染 前馈控制理论干预 心理情绪状态 疼痛情况 舒适度 生活质量

**Observation of the Effect of Feedforward Control Theory Intervention in Postpartum Care and Its Preventive Effect on Puerperal Infection/XIE Lijing. //Medical Innovation of China, 2025, 22(13): 097-101**

**[Abstract] Objective:** To explore the application effect of feedforward control theory intervention in postpartum care and its influence on puerperal infection. **Method:** A total of 94 puerpera who gave birth in Fuzhou Maternal and Child Health Hospital from April 2023 to April 2024 were selected. According to random number table

①抚州市妇幼保健院产科 江西 抚州 344000

通信作者：谢丽晶

- [9] 唐翀, 曾淑妃, 梁瀚文, 等. 广泛性焦虑障碍住院患者与健康对照者的认知功能比较研究 [J]. 中国全科医学, 2022, 25 (35): 4399-4405.
- [10] 唐雯琦, 马俊, 冯笑, 等. 心理弹性在 ICU 护士报警疲劳与职业压力的中介效应研究 [J]. 中国医药导报, 2022, 19 (36): 78-81.
- [11] 陈英, 陈晓洁, 王舒洁, 等. 芳香疗法联合情绪释放技术对失眠乳腺癌患者影响的研究 [J]. 中华护理杂志, 2022, 57 (6): 651-658.
- [12] 王志琳, 杨小普, 王园, 等. 基于 4R 模式的干预对胃癌化疗患者营养状况及疾病感知的影响 [J]. 癌症进展, 2023, 21 (21): 2399-2403.
- [13] 吴怡雪, 韩芷晴, 童莺歌, 等. 住院患者满意度测量问卷与患者就医体验调查问卷的比较研究 [J]. 中国卫生质量管理, 2023, 30 (6): 52-56.
- [14] 冯利娟. 急性白血病患者病程中灵性需求的特征性调查与目标干预的研究 [J]. 蚌埠医学院学报, 2021, 46 (6): 838-840.
- [15] 武玉慧, 徐征. 白血病患者生命意义的现状及其与生活质量、负性情绪的关系 [J]. 国际精神病学杂志, 2022, 49 (5): 860-862.
- [16] 朱茜茜, 杨惠云. 聚焦解决模式在慢性病自我管理中的应用研究进展 [J]. 护理学杂志, 2024, 39 (3): 126-129.
- [17] 曹桂英, 向巧君, 夏友, 等. 聚焦解决模式联合正念疗法改善艾滋病病人心理健康及应对方式的效果研究 [J]. 护理研究, 2022, 36 (10): 1842-1845.
- [18] 张兵, 杨红丽, 栾玉泉, 等. 聚焦解决模式对 HIV/AIDS 患者焦虑抑郁和心理弹性的干预研究 [J]. 中国艾滋病性病, 2022, 28 (9): 1050-1054.
- [19] 唐亚丽, 巫涵, 沈宏宇, 等. MPNFS 理论指导下多维度支持护理对急性白血病患者心理健康及照顾者负担的影响 [J]. 实用医院临床杂志, 2023, 20 (6): 126-130.
- [20] 陶豫洁, 李红, 高丽. 聚焦解决模式护理干预对白血病患者癌因性疲乏、心理韧性的影响 [J]. 临床心身疾病杂志, 2020, 26 (6): 83-85.
- [21] 陈娟. 聚焦解决模式心理护理对化疗期白血病患者心境状态、应对方式影响 [J]. 吉林医学, 2021, 42 (12): 3038-3040.

(收稿日期: 2024-09-03) (本文编辑: 何玉勤)